

2026년 제10차 약제급여평가위원회 사전 검토 보고

Leadership Brief | 2026.09.29 약평위 D-2 사전 점검

항목	내용
보고일	2026년 9월 29일(화) — 회의 D-2
회의	2026년 제10차 약제급여평가위원회
회의 예정일	2026년 10월 1일(목)
보고 대상	보험약가 / Market Access Leadership
보고 목적	10차 약평위 예상 안건, 약가·협상 합의, MSD 관점의 우선 확인 포인트 정리

1. Executive Snapshot

한 줄 결론: HIRA는 10차 약평위 사전 안건을 공개하지 않았고, 현재 공개 정보만으로 확정 후보를 특정하기 어렵다. 과거 암질심 전환 대기 후보인 사이람자·엘라히어·버제니오는 관찰 대상이지만 장기 대기만으로는 신뢰도가 낮아 High가 아닌 Watch로 관리하고, 비항암 희귀질환·신규 결정신청 및 기존 급여범위 확대 안건을 함께 열어두는 것이 안전하다.

핵심 메시지	Leadership Implication
9차에서 비항암 희귀질환과 late-line oncology가 함께 약평위에 진입했고, 항암 전환 후보 일부는 미상정됨	10차 후보 탐색은 항암 transition 단일 트랙이 아니라 비항암 희귀·혈액질환·후속치료까지 병렬화
사이람자·엘라히어·버제니오는 이전 차수에서 반복적으로 결과표에 나타나지 않음	경평소위·결정신청·가격수용 등 추가 product-level 신호 없이는 상정 우선순위를 과대평가하지 않음
결과 문구는 무조건부 적정·가격수용 조건부 적정·급여범위 확대를 구분해야 함	D+1에서 품목·적응증·조건별로 약가협상 진입과 등재 시점을 분리 판단

2. 직전 차수 결과 — 이번 회의의 기준선

제9차 약제급여평가위원회 (2026-09-03)

기준선	직전 공식 결과	이번 회의 연결 해석
결정신청	비브가트·질브리스큐·텍베일리·앤쥬고·프루자클라: 급여의 적정성이 있음	비항암 희귀·자가면역, 혈액암, 후속치료, 피부질환까지 후보 범주를 넓혀야 함
결정신청	림카토: 평가금액 이하 수용 시 급여의 적정성이 있음	고가 단위투여 CAR-T의 가격수용 조건과 협상 후속을 별도 추적
위험분담 사용범위 확대	옵디보 ESCC 및 옵디보+여보이 간세포암: 급여범위 확대의 적정성이 있음	기존 급여약제의 적응증·병용 확대가 신규 결정신청과 병렬로 진행될 수 있음
위험분담 사용범위 확대	옵디보+여보이 악성 흉막중피종: 급여범위 확대의 적정성이 없음	동일 조합도 적응증별 결과가 갈리므로 병용·질환 단위 분리 필요
전환 후보	사이람자·엘라히어·버제니오	장기 대기만으로는 충분한 상정 신호가 아니며 추가 공개 신호 확인 필요

9차는 비항암 희귀질환 품목과 late-line oncology가 함께 심의된 반면, 장기 대기 항암 후보가 모두 결과표에 포함되지 않았다. 10차에서도 후보군을 넓게 열되, 공개 근거가 약한 후보의 확산도는 보수적으로 유지해야 한다.

3. 제10차 약평위 예상 안건 — Leadership Watchlist

HIRA는 사전 안건을 공식 공개하지 않는다. 아래는 직전 공식 결과와 누적 공개 패턴을 바탕으로 한 관찰 우선순위이며, 실제 상정 여부와 심의 결과는 HIRA 공식 발표 이후 확정한다.

우선순위	약제/안건	회사	영역	현재 판단	Leadership 관찰 포인트
Watch	사이람자 (라무시루맵)	한국릴리	위암·위식도접합부 암	암질심 이후 장기 대기이나 8·9차 미상정	경평소위·결정신청·가격수용 신호와 실제 전환 여부 확인
Watch	엘라히어주 (미르베크시맵)	한국애브비	FRα 양성 백금저항성 난소암	희귀·난치성 전환 후보이나 공식 추가 신호 제한적	biomarker 대상군, 재정영향, 가격수용 준비와 상정 연결 여부 확인
Watch	버제니오정 (아베마시클립)	한국릴리	HR+/HER2- 조기 유방암 보조요법	OS 근거는 강하나 장기 투여·재정영향 부담, 9차 미상정	대상군 제한, 투여기간, 중단 기준, BIA 관리 문구 확인
Medium	비항암 희귀·자가면역 신약	복수 회사	신경면역·희귀혈액·피부질환	9차에서 복수 품목이 실제 진입한 범주	단독품목·비교약제 부재·환자군 제한에 따른 결과 문구 확인
Medium	late-line 혈액암·고형암 후속치료	복수 회사	다발골수종·전이성 결장직장암 등	9차 텍베일리·프루자클라 사례로 product registry 중요성 확인	이전 암질심·허가·결정신청 연결고리와 치료라인 조건 확인
Open	위험분담 사용범위·급여범위 확대	복수 회사	기존 급여약제	9차에서 적정·부적정이 적응증별로 분리	기존 급여 범위, 병용 파트너, 재정관리 조건을 안전별로 분리
Open	비공개 신규 결정신청	미확인	희귀질환·소아·혈액 질환 포함	사전 공개만으로 특정 불가	D+1 공식 결과표 전수 검토로 사전 신호 누락 방지

후보별 핵심 해석

사이람자: 암질심 통과 후 시간이 길다는 사실은 transition 병목을 보여주지만, 9차까지 반복 미상정되어 단독 예측 근거로는 약하다. 상정된다면 위암·위식도접합부암 치료라인, 도세탁셀 병용, 환자군과 가격수용 조건을 확인한다.

엘라히어: 희귀·난치성 항암제라는 정책적 중요성은 있으나, 실제 약평위 진입을 위해서는 공개된 결정신청·경평소위 또는 회사 가격수용 신호가 필요하다. 상정 시 FRα 검사와 대상환자 정의, 재정영향 관리가 핵심이다.

버제니오: 장기 OS 근거는 강점이지만 조기 유방암 보조요법은 장기 투여와 환자군 규모가 재정영향의 핵심 변수다. 결과 문구에서 임상적 인정과 재정관리 조건이 어떻게 결합되는지 확인해야 한다.

비항암·late-line 범주: 9차 결과는 항암 전환 후보만 추적하면 중요한 안건을 놓칠 수 있음을 보여준다. 10차는 희귀 신경면역·혈액질환·피부질환과 후속치료 제품을 함께 검색하고 D+1에서 공식 표 전체를 대조한다.

4. MSD 관점의 주요 영향

영역	관찰 내용	MSD 대응 관점
직접 안건	10차에서 MSD 품목의 공개 확정 신호는 없음	키트루다·파드셉 관련 약가·급여 후속 이슈를 약평위 후보와 분리해 지속 모니터링
병용·적응증 확대	9차에서 오피디보·여보이 조합이 적응증별로 상이한 결론을 받음	키트루다 병용 portfolio는 제품 단위가 아니라 적응증·치료라인·병용 파트너 단위로 관리
가격·협상	림카토의 가격수용 조건부 적정은 고가 치료제 협상의 선례	단회투여·고가 치료제의 평가금액 수용과 후속 협상 구조가 면역항암 협상에 주는 간접 영향 확인

영역	관찰 내용	MSD 대응 관점
경쟁 환경	셈블릭스 등 암질심 후보의 약평위 연결 여부가 혈액암 접근성 기준에 영향 가능	경쟁 약제의 기준문구를 환자군, 전환 조건, 재정관리 관점에서 비교

5. 결과 발표 후 확인해야 할 사항

확인 항목	왜 중요한가
사이람자·엘라히어·버제니오 실제 상정 여부	장기 대기만으로는 충분하지 않았던 transition 가설의 재검증
비항암 희귀·자가면역 품목 포함 여부	9차에서 확인된 범주 확장과 복수 신기전 동시 진입의 지속 여부 확인
late-line 혈액암·고형암 후속치료 포함 여부	9차의 텍베일리·프루자클라와 연결되는 product registry 보완
조건부 적정과 무조건부 적정 구분	평가금액 수용 여부에 따라 약가협상 진입 시점이 달라짐
급여범위 확대의 적정·부적정 적응증 분리	동일 조합·동일 성분의 결과를 약물 단위로 과대해석하지 않기 위해 필요
비공개 안전 전수 확인	사전 매체 신호가 없는 희귀질환·기존 급여기준 안전의 누락 방지

6. Source & Caveat

- 건강보험심사평가원 공식 보도자료와 세부 평가 문구가 10차 안전·결과의 최종 권위다.
- HIRA는 사전 안전을 공개하지 않으므로, 본 보고서의 watchlist는 공개된 직전 결과·전환 패턴·정책 신호를 바탕으로 한 관찰 목록이다.
- 사이람자·엘라히어·버제니오는 추가 product-level 신호가 확인되기 전까지 확정 후보가 아니라 Watch로 해석한다.
- 9차에서 확인된 비항암 희귀·late-line 범주는 10차의 탐색 우선순위이지, 특정 품목의 상정을 의미하지 않는다.
- 최종 상정·심의 결과·가격수용 조건은 2026년 10월 1일 이후 HIRA 공식 결과 공개 시 D+1 리뷰에서 확정한다.

본 보고서는 리더십 의사결정을 위한 독립 사전 검토 자료이며, 공개되지 않은 HIRA 내부 안전이나 회사의 비공개 협상 정보를 주장하지 않는다.